

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091690-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: JOSE FERREIRA FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS. LEI Nº 12.732/2012. VIOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA INÍCIO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROXIMIDADE DA DATA AGENDADA PARA CONSULTA ONCOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5091690-16.2024.4.02.5101

510015221979 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091690-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: JOSE FERREIRA FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pelo demandante em face de decisão interlocutória exarada pelo d. Juízo Substituto da 28ª VF do Rio de Janeiro que, a seu turno, indeferiu a tutela provisória de urgência em que pretendia **consulta oncológica no prazo de 5 dias** [evento 3, DESPADEC1, autos de origem], em razão de diagnóstico de **carcinoma de células escamosas**.

Aduz a recorrente que a **probabilidade do direito** estaria amparada nos documentos anexos à inicial, em que se comprova que o diagnóstico do recorrente ocorreu há mais de 60 dias, de modo que já teria sido esgotado o prazo da Lei nº 12.732/2012. Destaca, ainda, que a primeira consulta em oncologia (que é o pleito autoral) sequer é considerada pela legislação como o início do tratamento, e, ainda assim, foi agendada para 63 dias após o diagnóstico, postergando ainda mais o tratamento.

Já **risco ao resultado útil do processo** seria evidenciada pelo próprio quadro clínico desenhado pelos documentos médicos apresentados.

Indeferida a tutela recursal por esta relatora [evento 15, DESPADEC1].

Contrarrazões pelos recorridos [evento 22, CONTRAZ1 e evento 26, PET1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

*"Em breve síntese, o demandante recebeu diagnóstico de **carcinoma de células escamosas**, após exame histopatológico com resultado emitido em 23/09/2024 [evento 1, ANEXO4], conforme laudo médico confirmatório que instrui a inicial, nos autos de origem [evento 1, ANEXO7]. Foi encaminhado para consulta oncológica, para início do pertinente tratamento, com inserção no SER em 25/09/2024, e consulta agendada para 25/11/2024.*

Feitas estas considerações, não se pode olvidar que a Constituição Federal eleva o direito à saúde à categoria de garantia fundamental (art. 6º) de natureza prestacional, a que corresponde o dever de efetivação pelo Estado, por meio de políticas públicas levadas a cabo pela União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caracterizando verdadeira competência comum (art. 23, II) e responsabilidade solidária, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta linha de intelecção, a Lei 12.732/2012 dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo de 60 dias, a contar da confirmação do diagnóstico. Vejamos:

*Art. 2º **O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico** em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.*

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. (...)

*Na espécie, como destacado anteriormente, há informação de que o demandante/recorrente foi inserido no SER em **25/09/2024** e sua primeira consulta agendada para **25/11/2024**.*

Transcrevo passagem do parecer exarado pelo NAT-Jus:

*"No intuito de identificar o correto encaminhamento do Suplicante aos sistemas de regulação, este Núcleo consultou a plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER (ANEXO II) e verificou que ele foi **inserido em 25 de setembro de 2024 para ambulatório 1ª vez - cirurgia de cabeça e pescoço - exceto tireóide (oncologia) com classificação de risco vermelho e situação agendada para 25 de novembro de 2024, às 09:10h, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, sob a responsabilidade da central REUNI-RJ**".*

Os documentos anexos à inicial indicam que o demandante teve resultado de exame histopatológico emitido em 23/05/2024 e dois dias depois foi inserido no SER, o que se deu em 25/09/2024, com agendamento de consulta para 25/11/2024.

Se tomarmos a data do exame como diagnóstico da doença, temos que a consulta oncológica ocorrerá após 63 (sessenta e três) dias, vencido, portanto, o prazo fixado pela Lei 12.732/2012.

Apesar de reconhecida a violação formal ao prazo fixado pela lei de regência, entendo que a proximidade da data agendada para consulta (25/11/2024) torna despropositada a tutela provisória de urgência pretendida em sede recursal, porquanto o seu cumprimento dificilmente ocorreria antes do agendamento, considerados os prazos processuais de notificação dos recorridos.

*Por todo o exposto, em que pese demonstrada a **probabilidade do direito**, entendo ausente o **periculum in mora**, na forma do art. 300 do CPC, à luz da proximidade da consulta oncológica agendada administrativamente para 25/11/2024, a ensejar **INDEFERIMENTO da tutela recursal**."*

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

